SDD 225 Sujet n°1

Spécialité : CMF

Date : 30/10/2023
Auteur : Gregory Metzger (DES ORL, EDN 2023/2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 225 : découverte d'une anomalie cervico faciale à l'examen d'imagerie
Matériel nécessaire à la station	1 bureau et 2 chaises
Contexte de la station	

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences. Vous allez examiner Mathéo 15 ans qui vient de se prendre une balle de tennis dans l'oeil droit.

L'externe est allé l'examiner et vous décrit, hésitant, l'examen physique suivant : Le patient se plaint de nausées et vomissements et d'une douleur orbitaire très importante. Il semble exister aussi des troubles visuels, et la mobilité du globe oculaire semble limitée.

Le patient ne présente à priori pas d'épistaxis, ni de trouble de l'articulé dentaire ou de l'occlusion faciale. Il ne semble pas y avoir de plaie apparente ni endo-buccal, il n'existe pas d'otorragie. Ses constantes sont normales.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Indiquer les signes cliniques et/ou symptômes à rechercher lors de l'examen physique au vu de la lésion principale suspectée.

2. Demander un examen d'imagerie et l'interpréter.

3. Justifier les éléments de prise en charge.

Vous ne devez pas :
- interroger le patient
- interroger l'externe
- réaliser de prescription

Il s'agit d'une station sans patient standardisé

Fiche de correction pour l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1 – Signes / symptômes à rechercher à l'examen clinique.	
Recherche une limitation de l'élévation du globe oculaire	
Recherche une diplopie	
Recherche une hypoesthésie dans le territoire du nerf infra orbitaire	
Recherche une douleur à la palpation du rebord infra orbitaire	
Recherche une baisse de l'acuité visuelle	
Recherche un décalage en marche d'escalier au niveau du rebord infra orbitaire	
Tache 2 – Description de l'iconographie.	
Nom de l'examen réalisé : Scanner crânien et du massif facial non injecté	
Coupe : reconstruction coronale et/ou frontale du massif facial	
Identifie une fracture du plancher de l'orbite en trappe	
Identifie une possible incarcération du muscle droit inférieur	
Dit que le reste du cadre osseux et/ou parenchymateux est intact	
Tache 3 – Proposer une stratégie de prise en charge adaptée	
Énonce la nécessité d'une prise en charge chirurgicale	
Justifie le caractère urgent de cette chirurgie au vue des troubles visuels	
Énonce la nécessité de réaliser une désincarcération musculaire	
Contact le service de chirurgie maxillo-faciale afin de poursuivre la prise en charge	
COMPÉTENCES GENERIQUES	

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).